

PROTOCOLO DE ACESSO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ELETIVA/ AMBULATORIAL

Versão 1.0 – 2026



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE



MISSÃO

"Promover saúde e bem-estar para as pessoas."



VISÃO

"Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil."

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros – Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza – Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nádia Cristina Brach



GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

REVISÃO

Fabiane Voss

Thais Camile Bauer de Oliveira

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Nicole Schulka

Flávia Fontana Franco

Luna Azambuja

Carlos Henrique da Silva



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	09
2.INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO - RM.....	11
2.2 Grupos de atenção relativos ao método RM.....	13
2.2.1 Gestantes.....	13
2.2.2 Insuficiência renal.....	14
2.2.3 Sedação e Analgesia.....	14
3.CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO PARA RM.....	15
3.1 Quem pode solicitar.....	15
3.2 Orientações ao Profissional Solicitante.....	15
3.3 Conteúdo Descritivo Mínimo.....	15
3.4 Pré-requisitos e orientações para realização de RM.....	17
3.5 Informações complementares.....	16
4.SEGMENTOS - RESSONÂNCIA.....	18
4.1 RM de Crânio.....	18
4.1.1 Profissionais que podem solicitar RM de crânio.....	18
4.1.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Crânio.....	19
4.2 RM - Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral).....	19
4.2.1 Profissionais que podem solicitar RM - Articulação Temporo - Mandibular (Bilateral).....	20
4.2.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral).....	20
4.3 RM de Pescoço.....	21
4.3.1 Profissionais que podem solicitar RM - Pescoço.....	21
4.3.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Pescoço.....	21
4.4 RM De Tórax.....	21
4.4.1 Profissionais que podem solicitar RM - Tórax.....	22
4.4.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Tórax.....	22
4.5 RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra).....	23
4.5.1 Profissionais que podem solicitar RM de coluna.....	23
4.5.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra).....	24
4.6 RM do Abdome Superior.....	25
4.6.1 Profissionais que podem solicitar RM.....	26
4.6.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Superior.....	26
4.7 RM Abdome Inferior/ Bacia/ pelve.....	27
4.7.1 Critérios de Encaminhamento.....	27
4.7.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	27
4.7.3 Profissionais que podem solicitar RM.....	27



4.7.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Inferior / Bacia / Pelve.....	27
4.8 RM de membros e articulações.....	28
4.8.1 Critérios de Encaminhamento.....	28
4.8.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	28
4.8.3 Profissionais que podem solicitar RM de membros e articulações.....	28
4.8.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Membros e Articulações.....	29
4.9 RM De Vias Biliares/Colangiorressonância.....	30
4.9.1 Critérios de Encaminhamento.....	30
4.9.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	31
4.9.3 Profissionais que podem solicitar RM De Vias Biliares/Colangiorressonância...	31
4.9.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Vias Biliares / Colangiorressonância.....	31
4.10 RM De Coração/ Aorta C/ Cine.....	32
4.10.1 Critérios de Encaminhamento.....	32
4.10.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	33
4.10.3 Profissionais que podem solicitar RM de Coração / Aorta c/ Cine.....	33
4.10.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coração / Aorta c/ Cine.....	33
4.11 RM de Órbitas.....	34
4.11.1 Critérios de encaminhamento.....	34
4.11.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	34
4.11.3 Profissionais que podem solicitar RM de Órbitas.....	34
4.11.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Órbitas.....	34
4.12 RM De Ouvido/Mastóide/osso temporal.....	35
4.12.1 Critérios de Encaminhamento.....	35
4.12.2 Evidências Clínicas e Complementares.....	35
4.12.3 Profissionais que podem solicitar RM De Ouvido/Mastóide/osso temporal..	35
4.12.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Ouvido / Mastóide / Osso Temporal.....	35
4.13 RM de Sela Turcica.....	36
4.13.1 Critérios de Encaminhamento.....	36
4.13.2 Profissionais que podem solicitar RM de Sela Turcica.....	36
4.13.3 Evidências Clínicas e Complementares.....	36
4.13.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Sela Turcica.....	37
5.PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.....	38
6.RESULTADOS/ LAUDOS.....	39
REFERÊNCIAS.....	40



LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Crânio.....	19
Tabela 02 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral).....	20
Tabela 03 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Pescoço.....	21
Tabela 04 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Tórax.....	22
Tabela 05 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra).....	24
Tabela 06 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Superior..	26
Tabela 07 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Inferior / Bacia / Pelve.....	27
Tabela 08 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Membros e Articulações.....	29
Tabela 09 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Vias Biliares / Colangioressonância.....	31
Tabela 10 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coração / Aorta c/ Cine.....	33
Tabela 11 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Órbitas.....	34
Tabela 12 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Ouvido / Mastóide / Osso Temporal.....	35
Tabela 13 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Sela Turcica.....	37



LISTA DE QUADROS

Quadro 01 - Contraindicações ao Método RM.....	13
Quadro 02 - Características clínicas de lesão meniscal no joelho.....	29
Quadro 03 - Características clínicas de lesão ligamentar no joelho.....	30



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ADNPM - Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APS - Atenção Primária em Saúde
AVC - Acidente Vascular Cerebral
CBR - Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
CPRE - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica
DNPM - Desenvolvimento neuropsicomotor
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana
NMO - Neuromielite
RAS - Rede de Atenção à Saúde
RM - Ressonância Magnética
RMN - Ressonância Magnética Nuclear
SC - Santa Catarina
SIG-SaudeTech - Sistema Integrado de Gestão
SUS - Sistema Único de Saúde
TC - Tomografia Computadorizada
TCE - Traumatismo crânio encefálico
TEA - Transtorno do espectro autista
TEP - Tromboembolismo pulmonar
US/USG - Ultrassonografia



1.INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080/1990, garante o acesso universal, integral e equitativo às ações e serviços de saúde. A Política Nacional de Regulação, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, orienta a regulação em três dimensões: Regulação dos Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência.

A regulação assistencial, ou regulação do acesso, consiste na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime, sendo um instrumento fundamental para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por meio do processo regulatório, promove-se a resolução de casos que exigem ações articuladas em diferentes pontos de atenção, favorecendo a gestão racional dos recursos, a identificação de áreas críticas e a otimização do atendimento.

Considerando que os protocolos de acesso são instrumentos de ordenação dos fluxos de encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, orientando quanto à competência dos níveis de atenção.

A realização de exames de Ressonância Magnética (RM) desempenha papel essencial no diagnóstico e no tratamento de condições de saúde complexas. No âmbito do SUS, a utilização adequada desse exame torna-se ainda mais relevante, por se tratar de um recurso tecnológico avançado, geralmente de alto custo, cuja disponibilidade exige organização e gestão eficiente para garantir acesso equitativo à população. A adequada organização e otimização do acesso aos exames especializados contribuem para protocolos mais claros e intuitivos para os profissionais de saúde, além de melhor direcionamento às reais necessidades dos pacientes.

As subdivisões específicas para cada condição clínica facilitam o processo de solicitação e sua estratificação dentro do exame, permitindo um acesso mais rápido e eficiente ao exame correto, o que reduz erros e permite otimizar recursos, além de padronizar o fluxo de solicitações e fortalecer a integridade do processo de regulação.

O setor de regulação da Secretaria de Saúde do município desempenha um papel crucial ao organizar e priorizar o acesso à ressonância (RM), utilizando critérios como a classificação de risco e a necessidade clínica. Esse processo é fundamental para que o atendimento ocorra em tempo oportuno, evitando atrasos nos diagnósticos de condições que podem se agravar se não forem detectadas e tratadas rapidamente.



O manejo adequado dos recursos para exames de RM é fundamental para garantir o acesso justo e qualificado. A atualização contínua dos critérios de agendamento assegura que os profissionais de saúde tenham orientações claras e embasadas para a solicitação do exame, promovendo um atendimento mais resolutivo e integrado entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada. Dessa forma, a rede de saúde do SUS atinge seu objetivo de oferecer assistência eficaz, humanizada e em tempo hábil, beneficiando toda a comunidade.

E também, orientar a ação dos médicos reguladores, visando criar uma cultura em que o acesso à Atenção Especializada seja determinado por necessidades reais identificadas na atenção primária, após esta ter esgotado toda sua capacidade de condução do caso, mas com a consciência de que a Atenção Primária em Saúde (APS) é a responsável pelo acompanhamento de seus usuários.



2.INFORMAÇÕES REFERENTE AO MÉTODO - RM

A RM é uma técnica sofisticada não invasiva que utiliza campos magnéticos para obter imagens do corpo humano. Permite ao médico visualizar com alta definição as estruturas internas do corpo, como ossos, músculos, órgãos e vasos sanguíneos. A duração do exame de cada segmento varia entre 20 e 40 minutos.

Os principais riscos associados à realização da ressonância magnética se devem aos fortes campos magnéticos (magneto), que podem atrair/ movimentar objetos metálicos que estejam fora ou dentro do corpo do paciente, como por exemplo marcapassos, cliques de aneurisma e estilhaços de metal, que podem se mover ou aquecer. Outros riscos incluem claustrofobia, ansiedade e pânico durante o procedimento devido ao espaço fechado do aparelho; reações adversas a contrastes, que podem incluir náuseas ou reações alérgicas graves (embora raras). No quadro a seguir estão descritas as contraindicações:



Quadro 01 - Contraindicações ao Método RM / Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos (NGQP), 2026.

Absolutas	Relativas
• Bombas de infusão implantadas; • Cápsula endoscópica retida • Cateter de Swan-Ganz ou cateter com eletrodos ou dispositivo eletrônico; • Clamp carotídeo; • Clipes de aneurisma cerebral ferromagnético: Clipes cirúrgicos antigos podem mover-se e causar hemorragia. Os clipes modernos de titânio são seguros, mas exigem comprovativo médico. • Desfibrilador implantável; • Fios-guia intravasculares retidos; • Fios metálicos de localização pré-cirúrgica (exceto os pacientes com carta do médico solicitante informando material e compatibilidade com RM); • Halos Cranianos; • Holter; • Implantes dentários magnéticos; • Monitor de PIC (pressão intracraniana); • Neuroestimuladores e moduladores (espinhais/medulares, intestinais, vesicais e outros); • Prótese coclear metálica, implantes otológicos e aparelhos não removíveis; • Fixadores ortopédicos externos não removíveis; • Prótese ortopédica unilateral ou bilateral contraindicadas em caso de exames com sedação ou paciente confuso não contactantes; • Cânula de traqueostomia metálica (trocar para cânula plástica).	• Prótese mamária, prótese peniana, prótese ortopédica e implantes de aparelhos oculares:: desde que feita a consulta no manual de especificações do fabricante e/ou carta declarando compatibilidade com ressonância; • Válvula mitral metálica ou filtro de veia cava: o exame pode ser realizado desde que em aparelho de até 1,5 tesla e o paciente deve ter carta do médico solicitante informando material e compatibilidade com RM. • : desde que feita a consulta no manual de especificações do fabricante e/ou carta declarando compatibilidade com ressonância; • Projétil arma de fogo: consultar radiologista ou médico responsável pelo paciente e solicitar RX/scout prévios ao exame para afastar proximidade de estruturas e/ou vasos importantes; • Fragmento metálico ou corpo estranho: consultar radiologista ou médico responsável pelo paciente e solicitar RX/scout prévios ao exame para afastar proximidade de estruturas e/ou vasos importantes; • Tatuagem recente e maquiagem permanente: recomenda-se evitar o exame nos primeiros 30 dias após a tatuagem. • Cílios postiços magnéticos e piercings: devem ser obrigatoriamente removidos • Claustrofobia severa ou doentes não colaborativos; nesses casos a contraindicação contorna-se com a realização do exame sob sedação ou anestesia geral

Atenção: O Marca-passo (cardíaco e outros) – deve se checar o tipo/modelo do marcapasso e qual exame (aparelho) será realizado. Informações adicionais sobre a realização de exames de ressonância magnética em portadores de marca-passos podem ser obtidas no documento do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - (CBR). Orientações para realização de exames de ressonância magnética em portadores de dispositivos eletrônicos cardíacos e Painel Marca-passos cardíacos implantáveis, organizado e atualizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Inicialmente os riscos podem ser minimizados através de uma boa comunicação médico-paciente. O profissional médico solicitante deve sempre questionar ao paciente sobre qualquer implante metálico, cirurgia prévia e histórico de alergia a contrastes. Bem como orientar o mesmo para que no dia do exame remova objetos metálicos como jóias, piercings, relógios, presilhas e qualquer outro objeto metálico.

2.2 Grupos especiais de atenção ao uso do contraste

Protocolos estritos relativos ao uso do contraste intravenoso (Gadolínio)

2.2.1 Gestantes

A RM sem contraste é considerada segura em qualquer fase, mas diretrizes internacionais recomendam evitar o exame no 1º trimestre, a menos que seja uma urgência médica inadiável:

Em caso da necessidade de realização de ressonância magnética no primeiro trimestre, deverá ser apresentado um relatório do médico solicitante, explicando a necessidade do exame com as seguintes informações:

- que o diagnóstico não pode ser obtido através de outro método diagnóstico (exemplo ultrassom);
- a realização da RM é fundamental para a saúde materno-fetal;
- o exame não pode ser adiado para o segundo trimestre.



- O uso de **Gadolinio é contraindicado na gravidez**, pois atravessa a placenta, sendo utilizado apenas em casos extremos onde o risco de não fazer o exame supera o risco para o feto.

2.2.2 Insuficiência renal

- Pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave (taxa de filtração glomerular < 30 ml/min), deve-se evitar a injeção do meio de contraste (gadolinio). Portadores dessas patologias deverão trazer resultado de exame de creatinina realizado em até três meses.

2.2.3 Sedação e Analgesia

- A sedação e a analgesia são necessárias a depender das características do pedido do exame e do paciente. A sua aplicação, quando bem indicada, viabiliza procedimentos terapêuticos ou diagnósticos oportunos e bem-sucedidos. Com a grande variedade de pacientes e suas necessidades é imprescindível individualizar a sedação e analgesia para cada situação. Isso pode ser alcançado através da avaliação detalhada durante a solicitação do exame e no pré-procedimento do paciente. Indicações de sedação para realização do exame para paciente com idade inferior a 7 anos; Desorientação e ou agitação psicomotora; Neurotípicos que tentaram realizar o exame sem sucesso; Neurodiversos não colaborativos; Claustrofobia; Ventilação mecânica por intubação orotraqueal.

Importante: Pacientes em tratamento em outras instituições deverão levar o relatório de consulta pré-anestésica, sem contra indicação ao exame de RM com sedação; Obrigatório acompanhante maior de idade para pacientes menores de 18 anos; Assinar termos de consentimentos (encontrados no setor de RM).



3.CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO PARA RM

- Diagnóstico não realizado através de outros métodos de imagem (raio x, ultrassom, tomografia)
- Diagnóstico realizado apenas através do exame de RM (por exemplo, doenças desmielinizantes) ou que necessita de complementação através da RM (acompanhamento pós-cirúrgico de tumores do sistema nervoso central);
- Necessário indicação clínica detalhada.

3.1 Quem pode solicitar

As solicitações de RM via SUS são restritas aos médicos que compõem a RAS pública do município de Joinville. E devem ser solicitadas conforme orientação descrita neste protocolo, para cada tipo de ressonância

3.2 Orientações ao Profissional Solicitante

As solicitações de ressonância magnética a nível ambulatorial deverão ocorrer por meio do Sistema Integrado de Gestão SIG- Saudetech dentro do prontuário eletrônico na aba “Pedidos”, no item “Requisição de Procedimentos”.

Em nova janela preencher CID e no campo “Pesquisar Procedimento” e buscar pelo exame que deseja solicitar ex: RESSONÂNCIA. Abrirá lista dos segmentos disponíveis, selecionar o desejado e após selecionar “Condição Importante” e preencher os campos “Justificativa” e “Dados Clínicos para este Pedido”.

Todas as abas referente a solicitação do exame devem ser preenchidas obrigatoriamente.

Importante: No campo “Dados Clínicos para este Pedido” deve conter as informações solicitadas no próximo tópico deste documento “**CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO**”.

3.3 Conteúdo Descritivo Mínimo

- **Indicação Clínica:** principal motivo para solicitação do exame;



- **História Clínica:** Comorbidades que possam indicar ou contraindicar a realização do exame, tratamentos prévios (cirurgias, quimioterapia, radioterapia, etc), existência de metais no corpo; informação de alergia, história sucinta com tempo de evolução (data do início e detalhar a história e evolução do quadro) informando se há motivos clínicos para marcação em alta prioridade (categoria de priorização, de acordo com as tabelas de classificação de risco deste protocolo);
- **Exame Físico:** Achados relevantes e a presença de complicações ou doenças associadas, bem como uso de medicações que possam indicar ou contraindicar a realização do exame;
- **Hipótese diagnóstica:** Descrever hipótese diagnóstica.
- **Exames Complementares Prévios:** Descrever quais exames anteriores relacionados à região a ser examinada foram realizados e descrever os achados mais importantes desses laudos (Tomografia computadorizada (TC), RM, Raio-X, (RX)) exame do Líquor sem doença infecciosa);
- **Evidências clínicas e complementares:** Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: TC, RM, RX de sela túrcica, exame do líquido (se doença infecciosa).

Importante: Para os exames com finalidade de laudo comparativo é **obrigatório** que sejam levados os laudos anteriores.

3.4 Pré-requisitos e orientações para realização de RM

- Pedido médico preenchido adequadamente conforme “conteúdo descritivo mínimo”;
- Peso máximo suportado pelo aparelho de RM é de 150 kg;
- Quando o paciente tiver circunferência de quadril, abdômen e ombros acima do diâmetro do equipamento de ressonância (60 cm);
- Pacientes com idade superior a 7 anos, orientados e colaborativos.;
- Pacientes maiores de 7 anos, porém não colaborativos, avaliar a possibilidade de fazer a RM com sedação / anestesia geral;
- Caso tenha exames anteriores da região a ser examinada, realizados em outras



instituições, deverá trazê-los para comparação com o exame atual;

- Gestantes de preferência aguardar para fazer o exame após a 12ª semana;
- Tatuagens, cílios postiços (magnéticos ou colados) ou maquiagem definitiva recentes, antes de 1 mês, não se recomenda a realização da RM;
- Retirar colares, anéis, pulseiras, relógios, alianças, piercings;
- Mega-hair com anéis de metal, usados para prender extensões ao cabelo natural, deve ser retirado antes do procedimento;
- Cada segmento do exame de ressonância dura em média 30 minutos, os pacientes devem ser colaborativos e estar cientes que não poderão se movimentar durante todo o tempo que estiver ocorrendo a aquisição das imagens.

3.5 Informações complementares

A RM aplica-se para avaliação de pelve, neuroeixo ou para situações específicas em que se mostre superior ou complementar a TC, a qual constitui, de maneira geral, o exame padrão para o **estadiamento oncológico** de tórax e abdome.



4.SEGMENTOS - RESSONÂNCIA

4.1 RM de Crânio

A RM está indicada para pacientes que apresentem sinais e sintomas sugestivos de doença neurológica, cujo diagnóstico depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem de alta resolução, e cuja investigação não pode ser concluída por outros métodos disponíveis.

Principais indicações clínicas:

- Traumatismo crânio encefálico (TCE), para pacientes com possíveis sequelas;
- Avaliação de fossa posterior ou tronco cerebral;
- Processos inflamatórios/infecciosos;
- Tumores (diagnóstico e estadiamento);
- Metástases (detecção e acompanhamento);
- Processos Expansivos;
- Doenças degenerativas do encéfalo;
- Doenças desmielinizantes
- Aneurismas;
- Convulsões recentes a esclarecer;
- Cefaléia com sinais de alerta e mudanças no padrão pré existente
- Malformações; Hidrocefalia.
- Atraso DNPM (atraso desenvolvimento neuropsicomotor)
- Paralisia cerebral
- Autismo

Atenção: A indicação de RM de crânio em pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Atraso no DNPM deve restringir-se aos casos com achados neurológicos focais, alterações significativas do perímetro cefálico ou outros sinais clínicos que justifiquem investigação estrutural.

4.1.1 Profissionais que podem solicitar RM de crânio

Clínico geral, médico de família e comunidade, cirurgião de cabeça e pescoço,



dermatologista, endocrinologista, geriatra, infectologista, neurocirurgião, neurologista, oncologista, ortopedista, psiquiatra.

4.1.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Crânio

Tabela 01 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Crânio

CÂNCER/ SUSPEITO	Pesquisa de metástase cerebral, forte suspeita de tumor.
P1	Traumatismo de crânio, suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) em fase subaguda/crônica, trombose venosa cerebral, cefaléia com sinais de alarme, esclerose múltipla, malformações vasculares, sinais clínicos sugestivos de hipertensão intracraniana idiopática, crise convulsiva a esclarecer de origem recente, encefalite, suspeita de mielite, neuromielite óptica (NMO), síndrome demencial de início agudo. Atraso DNPM, paralisia cerebral, autismo.
P2	Avaliação de cefaléia sem sinais de alarme, distúrbios do movimento, acompanhamento de doenças desmielinizantes conhecidas, hidrocefalia compensada.
P3	Doenças neurodegenerativas conhecidas em acompanhamento, avaliação de sequelas de trauma craniano leve, estudo anatômico sem sintomas clínicos relevantes.

Elaborado: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos (NGQP), 2026.

4.2 RM - Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral)

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

Principais indicações clínicas:

- Tumores;
- Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos);
- Derrames articulares (suspeita);



- Doenças reumatológicas (artrite reumatoide, lúpus e outros);
- Fraturas Ocultas;
- Traumatismos articulares;
- Distúrbios articulares não diagnosticados por exames de menor complexidade;
- Estudo do ouvido e das mastóides;
- Perdas Auditivas; Zumbidos; Labirintites e Malformações.

4.2.1 Profissionais que podem solicitar RM - Articulação Temporo - Mandibular (Bilateral)

Clínico geral, médico de família e comunidade (por indicação de teleconsultoria ou regulador) e médicos de outras especialidades.

4.2.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral).

Tabela 02 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Articulação Temporo-Mandibular (Bilateral).

CÂNCER/ SUSPEITO	Tumores.
P1	Traumatismos, pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face.
P2	Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos).
P3	Derrames articulares (suspeita), Doenças reumatológicas (artrite reumatoide, lúpus e outros).

Elaborado: NGQP, 2026.



4.3 RM de Pescoço

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

Principais indicações clínicas:

- Pesquisa de foco de infecção;
- Lesões expansivas e estadiamento local;
- Nódulo de tireoide com sintomas compressivos - Complementar ao estudo ultrassonográfico;
- Pesquisa de adenomegalia - Complementar ao estudo ultrassonográfico.

4.3.1 Profissionais que podem solicitar RM - Pescoço

Clínico geral e médico de família e comunidade (por indicação de teleconsultoria ou regulador) e médicos de outras especialidades.

4.3.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Pescoço.

Tabela 03 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Pescoço.

CÂNCER/ SUSPEITO	Forte suspeita de lesões tumorais.
P1	Pesquisa de foco de infecção e nódulos de tireoide com sintomas compressivos.
P2	Pesquisa de adenomegalia.

Elaborado: NGQP, 2026.

4.4 RM De Tórax

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.



Principais indicações:

- Alterações mediastinais - parede torácica - não esclarecidas por TC prévia;
- Rouquidão por lesão do laríngeo recorrente - não esclarecidos por TC prévia;
- Avaliar anomalias do arco aórtico - não esclarecidas por TC prévia;
- Tumores neurais, mediastinais e hilares - diagnóstico e estadiamento não esclarecidos por TC prévia;
- Avaliação das artérias pulmonares (Hipertensão Arterial Pulmonar) - não esclarecidos por TC prévia;
- Detecção e caracterização de nódulos pulmonares não esclarecidos por TC prévia;
- Doença tromboembólica pulmonar não esclarecida por TC prévia;
- Síndrome de compressão da veia cava superior;
- Doenças da aorta (aneurisma/dissecção - não esclarecidos por TC prévia;
- Tromboembolismo pulmonar (TEP) - não esclarecidos por TC prévia.

4.4.1 Profissionais que podem solicitar RM - Tórax

Da atenção básica, poderá ser solicitado pelo clínico geral e médico de família e comunidade (por indicação de teleconsultoria ou regulador) e médicos de outras especialidades.

4.4.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Tórax.

Tabela 04 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Tórax.

CÂNCER/ SUSPEITO	Lesões tumorais pulmonares, mediastinais e hilares não esclarecidas por exame tomográfico prévio.
P1	Traumatismo, hemoptise, diagnóstico e estadiamento de tumores, TEP, dissecção de aorta, fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural - não esclarecidos por TC prévia.
P2	Síndrome de compressão da veia cava superior, pneumopatias Intersticiais - não esclarecidos por TC prévia.



P3	Nódulos não neoplásicos (avaliação e acompanhamento) - não esclarecidos por TC prévia.
-----------	--

Elaborado: NGQP, 2026.

4.5 RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra)

É indicada para pacientes com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende essencialmente do exame de imagem, após esgotados outros métodos disponíveis. A solicitação direta é pertinente quando a avaliação clínica documentar sinais de alarme (sistêmicos ou neurológicos) ou fatores de risco que exijam investigação por método de alta sensibilidade.

A solicitação de RM de coluna é indicada prioritariamente nas seguintes condições:

- Complicações pós-operatórias - não esclarecidas pelo método tomográfico;
- Doença desmielinizante;
- Hérnia de disco;
- Investigação de mielopatias;
- Investigação de tuberculose extra-pulmonar;
- Malformações congênitas;
- Metástases;
- Mielopatia aguda;
- Patologias inflamatórias, ósseas, musculares, ligamentares e cartilaginosas;
- Processos expansivos;
- Traumas;
- Tumores Ósseos Primários (suspeita).

4.5.1 Profissionais que podem solicitar RM de coluna

Da atenção básica, poderá ser solicitado pelo clínico geral e médico de família e comunidade (por indicação de teleconsultoria ou regulador) e médicos de outras especialidades.



4.5.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra).

Tabela 05 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coluna (Cervical ou Torácica ou Lombar ou Lombo-Sacra).

CÂNCER/ SUSPEITO	Investigação de processo expansivo, diagnóstico e estadiamento de tumor/metástases.
P1	Suspeita de estenose de canal medular, controle de processos infecciosos, suspeita de fratura oculta ou duvidosa, trauma recente.
P2	Hérnia discal, má formação congênita (hemi-vértebras).

Elaborado: NGQP, 2026.

IMPORTANTE

DOR LOMBAR: Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para exame de imagem (RM – preferencialmente – ou TC), se raio-X normal ou inconclusivo.

Dor lombar com sinais de alerta, sem indicação de avaliação emergencial:

- Sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que 70 anos ou menor que 20 anos;
- Paciente com história prévia ou suspeita de câncer;
- Paciente com imunossupressão (Vírus da imunodeficiência humana (HIV), uso crônico de corticóides ou outros imunossupressores);
- Presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso de maneira involuntária, febre);
- Dor com característica não mecânica (não relacionada à atividade/repouso)
- Dor predominantemente noturna;
- Paciente com diagnóstico prévio de osteoporose;
- Dor lombar com duração maior que 8 semanas, sem resposta ao tratamento clínico otimizado.

DOR CERVICAL: Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para exame de imagem (RM – preferencialmente – ou TC), se raio-X normal ou inconclusivo. Dor cervical com sinais de alerta, sem indicação de avaliação emergencial:



- Sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que 70 anos ou menor que 20 anos;
- Paciente com história prévia ou suspeita de câncer;
- Paciente com imunossupressão (HIV, uso crônico de corticóides ou outros imunossupressores);
- Presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso de maneira involuntária, febre);
- Paciente com diagnóstico prévio de osteoporose;
- Dor cervical com duração maior que 8 semanas, sem resposta ao tratamento clínico otimizado.

4.6 RM do Abdome Superior

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

A solicitação de RM do Abdome Superior é indicada prioritariamente nas seguintes condições:

- Pacientes com contraindicação para realização de Tomografia Computadorizada (alergia a iodo, gestantes);
- Avaliação morfológica de órgãos abdominais (fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares, baço, rins, alças intestinais e estruturas vasculares) para pesquisa e diagnóstico de alterações congênitas, inflamatórias, neoplásicas, degenerativas e/ou traumáticas;
- Avaliação pré-operatória;
- Fígado: Caracterização de nódulos atípicos ao US e TC. Detecção de nódulos em pacientes com esteatose hepática moderada/importante (sensibilidade maior que o US e TC). Pacientes com cirrose hepática e suspeita de carcinoma hepatocelular (sensibilidade maior que o US e TC). Avaliação dos nódulos hepáticos pós-tratamento com quimioterapia;
- Suspeita de hiperferritinemia: Casos em que a avaliação da carga de ferro deve ser considerada. Aqueles que apresentarem alteração laboratorial de Saturação de transferrina >50% sem causa clara; Ferritina >1000 ug/L com saturação de transferrina normal e sem explicação óbvia; Ferritina >1000 ug/L com fatores de



risco para doença hepática; entre outros;

- Pâncreas: Estadiamento dos tumores (sensibilidade maior que a do US);
- Vias Biliares: Avaliar dilatação das vias biliares. Pesquisa de obstrução (Colelitíase, Coledocolitíase / Sensibilidade semelhante à CPRE para cálculos). Pesquisa e estadiamento de tumores (sensibilidade maior que a da TC);
- Vias urinarias e adrenais: Caracterização de nódulos atípicos ao US e TC. Estadiamento de tumores de células renais. Suspeita de feocromocitoma ou adenoma da adrenal.

4.6.1 Profissionais que podem solicitar RM

Médicos da Atenção Primária à Saúde e de outras especialidades.

4.6.2 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Superior.

Tabela 06 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Superior.

CÂNCER/ SUSPEITO	Tumores (diagnóstico e estadiamento) - não esclarecidos por TC prévia.
P1	Pacientes com contraindicação para realização de Tomografia Computadorizada (alergia a iodo, gestantes); Detecção de nódulos em pacientes com esteatose hepática grave (sensibilidade maior que o US e TC); Aneurisma sintomático, hiperplasia prostática, pancreatite aguda, suspeita de abscessos, dor associadas a sinais de alarme, investigação de linfonodomegalia, doenças biliares, hepáticas, pancreáticas não esclarecidas por TC prévia.
P2	Controle de aneurisma, suspeita de hiperferritinemia, pancreatite crônica ou linfonodomegalia, não esclarecidos por TC prévia.
P3	Investigação de dor abdominal crônica não esclarecida por TC prévia.

Elaborado: NGQP, 2026.



4.7 RM Abdome Inferior/ Bacia/ pelve.

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.7.1 Critérios de Encaminhamento

- Patologias inflamatórias ou degenerativas, ósseas, musculares, ligamentares e cartilaginosas;
- Neoplasias de partes moles e ósseas;
- Avaliação morfológica fetal, complicações da gravidez (ex. acretismo placentário);
- Doença inflamatória pélvica (ex. sítios de endometriose / cistos anexiais complicados);
- Avaliação do trato intestinal baixo;
- Avaliação geniturinária (bexiga, próstata e útero);
- Malformações congênitas.

4.7.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: RX, USG ou TC com laudo, se houver.

4.7.3 Profissionais que podem solicitar RM

Médicos da Atenção Primária à Saúde e de outras especialidades.

4.7.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Inferior / Bacia / Pelve.

Tabela 07 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Abdome Inferior / Bacia / Pelve.



CÂNCER/ SUSPEITO	Formações expansivas, tumorais ou suspeitas e metástases, notadamente de lesões útero-ovarianas e prostáticas.
P1	Aneurisma sintomático, suspeita de abscessos, dor após traumatismos. Investigação de linfonodomegalia, hematúria a esclarecer, fístula vesical, suspeita de endometriose.
P2	Controle de aneurisma, linfonodomegalia, investigação de dor abdominal crônica - não identificada por exame ultrassonográfico/tomográfico prévio.

Elaborado: NGQP, 2026.

4.8 RM de membros e articulações

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.8.1 Critérios de Encaminhamento

- Malformações congênitas;
- Neoplasias de partes moles e ósseas;
- Patologias inflamatórias ou degenerativas, ósseas, musculares, ligamentares e cartilaginosas;
- Traumas.

4.8.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: RX, USG ou TC com laudo, se houver.

4.8.3 Profissionais que podem solicitar RM de membros e articulações

Médicos da Atenção Primária à Saúde e de outras especialidades.



4.8.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Membros e Articulações.

Tabela 08 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Membros e Articulações.

CÂNCER/ SUSPEITO	Processo expansivo, fratura patológica, tumores (diagnóstico, estadiamento).
P1	Má formação congênita sintomática.
P2	Patologias degenerativas ou inflamatórias, ósseas, musculares, ligamentares e cartilaginosas - não esclarecidas por RX / TC ou ultrassonografia prévia - ou cujo diagnóstico seja exclusivo do estudo por RM.
P3	Investigação de dor articular crônica - não esclarecidas por TC prévia.

Elaborado: NGQP, 2026.

IMPORTANTE

DOR NO JOELHO: Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Ressonância Magnética Nuclear – RMN - do joelho: suspeita clínica de lesão meniscal ou ligamentar do joelho (Conforme quadro abaixo).

Quadro 02 - Características clínicas de lesão meniscal no joelho

Suspeita clínica de lesão meniscal no joelho
Sintomas que iniciaram após traumatismo (atividades esportivas).
Dificuldade para agachar ou ajoelhar.
Bloqueio articular.
Derrame articular.
Dor a palpação da interlinha articular.



Anormalidade na movimentação do joelho: diminuição de movimento passivos ou incapacidade de estender completamente o joelho.
Teste de McMurray positivo.

Fonte: Telessaúders-UFRGS (2015).

Quadro 03 - Características clínicas de lesão ligamentar no joelho

Suspeita clínica de lesão ligamentar no joelho
Sintomas que iniciam após traumatismo (atividade esportiva) especialmente se associado à derrame articular precoce (primeiros instantes após o trauma).
Sensação de instabilidade articular.
Frouxidão ligamentar (maior amplitude de movimento).
Positividade em testes que avaliam a integridade ligamentar: -Gaveta anterior; -Lachman; -Pivot-shift.

Fonte: Telessaúders-UFRGS (2015).

4.9 RM De Vias Biliares/Colangiorressonância

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.9.1 Critérios de Encaminhamento

- Avaliação morfológica de órgãos abdominais (fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares, baço, rins, alças intestinais e estruturas vasculares);
- Pesquisa e diagnóstico de alterações congênitas, inflamatórias, neoplásicas, degenerativas e/ou traumáticas;
- Pesquisa de complicações da colecistite aguda;
- Estadiamento dos tumores (sensibilidade maior que a do US);



- Vias Biliares: Avaliar dilatação das vias biliares; Pesquisa de Obstrução (Colelitíase, Coledocolitíase / Sensibilidade semelhante à CPRE para cálculos);
- Pesquisa e Estadiamento de tumores avaliação pré-operatória dos tumores das vias biliares;
- Colangiopancreatografia por RM (avaliação do Ducto de Wirsung e colédoco).

4.9.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: RX, USG ou TC com laudo, se houver.

4.9.3 Profissionais que podem solicitar RM De Vias Biliares/Colangiorressonância

Cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, gastroenterologista, infectologista, oncologista.

4.9.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Vias Biliares / Colangioressonância.

Tabela 09 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Vias Biliares / Colangioressonância.

CÂNCER/ SUSPEITO	Lesões expansivas, estadiamento de tumores , suspeita de tumores e processos obstrutivos de vias biliares. Colangiopancreatografia por RM (avaliação do Ducto de Wirsung e colédoco).
P1	Avaliação morfológica de órgãos abdominais, complicações da colecistite aguda.
P2	Alterações congênitas, inflamatórias, degenerativas e/ou traumáticas.

Elaborado: NGQP, 2026.



4.10 RM De Coração/ Aorta C/ Cine

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.10.1 Critérios de Encaminhamento

- **Cardiopatias Congênitas:** Segmento de cardiopatias congênitas do adulto; Avaliação de shunt sistêmico-pulmonar (Qp/Qs).
- **Anomalias de situs víscero-atrial:** Anomalias de situs com cardiopatias congênitas complexas.
- **Anomalia atrial e do retorno venoso:** Retorno venoso pulmonar anômalo, especialmente em anomalias complexas e cor triatriatum; Retorno venoso sistêmico anômalo; Obstrução de retorno venoso pulmonar ou sistêmico após reparo intra-atrial ou correção de retorno venoso pulmonar anômalo.
- **Anomalias dos ventrículos:** Comunicação interventricular associada com anomalias complexas; Comunicação interventricular supracristal; Avaliação da função ventricular, massa e volumes direito e esquerdo; Aneurismas e divertículos ventriculares.
- **Anomalias das valvas semilunares:** Estenose aórtica supravalvar; Regurgitação pulmonar; Estenose pulmonar supra valvar.
- **Anomalias das artérias:** Avaliação pós-operatória de shunts; Aneurismas do seio de Valsava; Coarctação da aorta; Anéis vasculares; Janela aorta-pulmonar; Origem anômala de coronárias em adultos e crianças maiores; Atresia pulmonar; Estenose pulmonar proximal; Colaterais sistêmico-pulmonares; Má-posição dos grandes vasos.
- **Doenças Vasculares:** Indicações de RM (ressonância magnética cardíaca) na avaliação das doenças vasculares: Aneurismas de aorta (incluindo Marfan); Dissecção de aorta; Ruptura de aorta; Hematoma intramural aórtico; Úlceras aórticas; Planejamento de abordagem cirúrgica da aorta; Planejamento de stent aórtico; Arterites; Anatomia da artéria pulmonar e fluxo; Avaliação das veias Pulmonares; Avaliação de estenoses renais; Avaliação de estenoses carótidas extracranianas.
- **Indicações de RM na avaliação da doença arterial coronária:** Avaliação da função ventricular global, volumes e massa (esquerda e direita); Detecção isquemia miocárdica - Avaliação da função ventricular regional em repouso e em estresse (RM-estresse) e Avaliação da perfusão miocárdica; Infarto agudo e crônico do miocárdio: Detecção e



quantificação; Viabilidade miocárdica; Trombo ventricular; Avaliação de aneurisma de VE; Diagnóstico de síndrome coronária na fase aguda Indicações de RM na avaliação das cardiomiopatias: Cardiomiopatia hipertrófica; Cardiomiopatia dilatada – diagnóstico diferencial com etiologia isquêmica; Displasia/cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito; Cardiomiopatia siderótica, especialmente secundária a talassemia; Miocárdio não compactado; Cardiomiopatia chagásica; Miocardite (fase aguda ou crônica); Diagnóstico diferencial do coração de atleta; Cardiomiopatia restritiva; Sarcoidose cardíaca.

• **Indicações de RM na avaliação de doenças pericárdicas tumores e trombos:** Detecção e caracterização de tumores cardíacos e pericárdicos; Detecção e diagnóstico diferencial de trombos ventriculares; Pericardite constrictiva. Indicações de RM na avaliação das doenças valvares: Avaliação da anatomia função ventricular; Quantificação da regurgitação.

4.10.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: USG ou TC com laudo, se houver.

4.10.3 Profissionais que podem solicitar RM de Coração / Aorta c/ Cine

Angiologista, cardiologista, cirurgião cardiovascular, cirurgião pediátrico, cirurgião torácico, cirurgião vascular e pneumologista.

4.10.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coração / Aorta c/ Cine.

Tabela 10 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Coração / Aorta c/ Cine.

CÂNCER/ SUSPEITO	Avaliação de doenças pericárdicas, tumores e trombos.
P1	Todos as demais indicações cujos diagnósticos não puderam ser realizados através de outros métodos diagnósticos.

Elaborado: NGQP, 2026.



4.11 RM de Órbitas

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.11.1 Critérios de encaminhamento

- Oftalmopatia de Graves.
- Trauma ocular
- Pesquisa de lesões expansivas
- Pseudotumores
- Patologias inflamatórias, infecciosas e vasculares das estruturas orbitárias cujo diagnóstico não foi possível através de outros métodos

4.11.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: USG ou TC com laudo, se houver.

4.11.3 Profissionais que podem solicitar RM de Órbitas

Neurocirurgião, neurologista, oftalmologista e oncologista.

4.11.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Órbitas.

Tabela 11 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Órbitas.

CÂNCER/ SUSPEITO	Pesquisa de lesões expansivas.
P1	Oftalmopatia de Graves; Trauma ocular; Patologias inflamatórias, infecciosas e vasculares das estruturas orbitárias cujo diagnóstico não foi possível através de outros métodos.

Elaborado: NGQP, 2026.



4.12 RM De Ouvido/Mastóide/osso temporal

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.12.1 Critérios de Encaminhamento

- Estudo do ouvido interno;
- Estudo das mastóides;
- Perdas auditivas;
- Zumbidos no ouvido;
- Suspeita de tumores do conduto auditivo;
- Alterações vasculares;
- Malformações;
- Labirintites.

4.12.2 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: USG ou TC com laudo, se houver.

4.12.3 Profissionais que podem solicitar RM De Ouvido/Mastóide/osso temporal

Neurocirurgião, neurologista, oncologista e otorrinolaringologista.

4.12.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Ouvido / Mastóide / Osso Temporal.

Tabela 12 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Ouvido / Mastóide / Osso Temporal.



CÂNCER/ SUSPEITO	Suspeita de tumores do conduto auditivo.
P1	Estudo do ouvido interno; Estudo das mastóides; Perdas auditivas; Alterações vasculares; Malformações.
P2	Labirintites; Zumbidos no ouvido sem outras patologias associadas.

Elaborado: NGQP, 2026.

4.13 RM de Sela Turcica

Paciente apresentando sinais e sintomas suspeitos e compatíveis com hipótese diagnóstica cujo desfecho depende de forma exclusiva ou complementar do exame de imagem não sendo possível sua realização através dos outros métodos disponíveis.

4.13.1 Critérios de Encaminhamento

- Investigação de avaliação de adenomas e distúrbios hormonais hipofisários.
- Puberdade precoce.
- Atraso de crescimento e desenvolvimento.
- Investigação de hiperprolactinemia, hipogonadismo hipogonadotrófico, gigantismo, acromegalia, tumores das regiões parasselar e suprasselar e lesões do seio cavernoso.
- Avaliação pré-operatória e pós-operatória de tumores da região selar, parasselar e suprasselar.

4.13.2 Profissionais que podem solicitar RM de Sela Turcica

Médicos da Atenção Primária à Saúde e de outras especialidades.

4.13.3 Evidências Clínicas e Complementares

Considerar na abordagem inicial do paciente, a idade, história clínica, exame físico e a presença ou não de complicações ou doenças associadas, medicações em uso; Informar laudo de exames anteriores: USG ou TC com laudo, se houver.



4.13.4 Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Sela Turcica

Tabela 13 - Classificação de Risco/ Protocolo de Regulação - RM de Sela Turcica.

CÂNCER/ SUSPEITO	Investigação e avaliação de adenomas hipofisários, gigantismo, acromegalia, tumores das regiões parasselar e suprasselar e hiperprolactinemia, hipogonadismo hipogonadotrófico, lesões do seio cavernoso, avaliação pré-operatória e pós-operatória de tumores da região selar, parasselar e suprasselar.
P1	Investigação de distúrbios hormonais hipofisários, puberdade precoce, atraso de crescimento e desenvolvimento.

Elaborado: NGQP, 2026.



5. PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME

O preparo para realização do exame é orientado pelo prestador do serviço ao usuário.



6.RESULTADOS/ LAUDOS

Os laudos devem ser retirados pelo usuário ou representante legal do mesmo, conforme orientação do prestador do exame. Respeitando a LGPD.

REFERÊNCIAS

ALAMRI, A. et al. Identifying Clinical Clues in Children With Global Developmental Delay / Intellectual Disability With Abnormal Brain Magnetic Resonance Imaging (MRI). **Journal of Child Neurology**, [s. l.], v. 36, n. 6, p. 432-439, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/0883073820977330>.

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de Acesso à Ressonância Magnética**. Belo Horizonte, [202-?]. Disponível em: <https://fluxosusbh.pbh.gov.br/anexos/ec785e772d5d29228904a1b2454fdd25e9f6a074.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2026.

COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CBR). **Ressonância Magnética**. São Paulo: CBR, set. 2024. Disponível em: <https://cbr.org.br/wp-content/uploads/2024/09/RESSONANCIA-MAGNETICA-1.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2026.

EVANS, R. W. et al. Neuroimaging for Migraine: The American Headache Society Systematic Review and Evidence-Based Guideline. **Headache**, [s. l.], v. 60, n. 2, p. 318-336, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/head.13720>.

HAYES, L. L. et al. ACR Appropriateness Criteria Headache-Child. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 15, n. 5S, p. S78-S90, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2018.03.017>.

JULIANO, A. F. et al. ACR Appropriateness Criteria Ataxia. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 16, n. 5S, p. S44-S56, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2019.02.021>.

LEE, J. Y. et al. Requirement for Head Magnetic Resonance Imaging in Children Who Present to the Emergency Department With Acute Nontraumatic Visual Disturbance. **Pediatric Emergency Care**, [s. l.], v. 35, n. 5, p. 341-346, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001506>.

LEE, R. K. et al. ACR Appropriateness Criteria® Seizures and Epilepsy. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 17, n. 5S, p. S293-S304, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.01.037>.

LUTTRULL, M. D. et al. ACR Appropriateness Criteria Acute Mental Status Change, Delirium, and New Onset Psychosis. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 16, n. 5S, p. S26-S37, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2019.02.024>.

RATH, T. J. et al. ACR Appropriateness Criteria® Cranial Neuropathy: 2022 Update. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 19, n. 11S, p. S266-S303, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2022.09.021>.

RYAN, M. E. et al. ACR Appropriateness Criteria® Head Trauma-Child. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 17, n. 5S, p. S125-S137, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.01.026>.



SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Saúde. **Protocolos de acesso GR SES-SP: exames RM. 2. ed.** São Paulo, ago. 2024. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage//protocolos_de_acesso_gr_sessp_-_exames_rm_2_versao_atualizada_ago-2024.pdf. Acesso em: 13 mar. 2026.

SIDOROV, E. et al. Criteria for Emergency Brain MRI During Stroke-Alert. **Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases**, [s. l.], v. 30, n. 8, p. 105890, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.105890>.

SIVAKUMAR, S. et al. Appropriateness of Brain MRI Orders from the Emergency Department: An Academic Radiology Department's Experience. **Cureus**, [s. l.], v. 13, n. 4, e14771, 2021. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.14771>.

TROFIMOVA, A. et al. ACR Appropriateness Criteria® Seizures-Child. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 18, n. 5S, p. S199-S211, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2021.02.020>.

UBERABA. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo Ressonância Magnética.** Uberaba: SMS, [202-?]. Disponível em: <http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/acervo//saude/arquivos/protocolos%20de%20acesso/PROTOCOLO%20RESSONANCIA%20MAGNETICA.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2026.

WHITELEY, W. N. et al. Clinical Diagnosis and Magnetic Resonance Imaging in Patients With Transient and Minor Neurological Symptoms: A Prospective Cohort Study. **Stroke**, [s. l.], v. 53, n. 11, p. 3419-3428, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.039082>.

WOOTTON-GORGES, S. L. et al. ACR Appropriateness Criteria Suspected Physical Abuse-Child. **Journal of the American College of Radiology**, [s. l.], v. 14, n. 5S, p. S338-S349, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacr.2017.01.036>.

